Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Júlio de Castilhos

Avenida Fernando Abott, 875 - Bairro: Centro - CEP: 98130000 - Fone: (55) 3029-9967 - www.tjrs.jus.br - Email: frjulcastvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000400-90.2023.8.21.0056/RS

AUTOR: COLOIR MACHADO DA SILVA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

COLOIR MACHADO DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em face do IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL. Alegou ter diagnóstico de Neoplasia maligna de outras glândulas salivares e Neoplasia Maligna Secundária Dos Órgãos Respiratórios e Digestivos, CID 10 C08 e CID78.0. Disse que, em razão de sua enfermidade, necessitava fazer a aplicação do medicamentos PERTUZUMABE + TRASTUZUMABE, nos moldes do laudo médico juntado. Afirmou que lhe foi negado o fornecimento da medicação administrativamente, em razão do tratamento não estar previsto nas recomendações técnicas de cobertura dos tratamentos oncológicos do Sistema Ipê Saúde. Requereu, em sede antecipatória do mérito, o fornecimento pelos réu do fármaco acima referido, com a taxa de sala, materiais e/ou medicamentos inerentes a aplicação hospitalar. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada. Juntou documentos.

Deferido o pedido de gratuidade judiciária e concedida a medida liminar (evento 3, DESPADEC1).

Em contestação, o réu asseverou a ausência de cobertura contratual do medicamento requerido pela autora. Discorreu acerca da legislação que rege a matéria, concluindo pela legitimidade da negativa de cobertura. Requereu a improcedência e juntou documentos (evento 18, CONT1).

Houve réplica.

As partes informaram que não há mais provas a produzir (26.1 e 26.1)

É o relatório.

Em que pese o feito estivesse destinado ao saneamento, verifico que há nos autos elementos suficientes para uma conclusão segura, à luz dos articulados, documentos e posturas processuais das partes, o que permite a dispensa de outras provas, por desnecessárias, e o julgamento antecipado do mérito, consoante artigo 355, inciso I, do CPC, conforme restará evidenciado no curso desta fundamentação.

Tratando-se de contrato de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul (IPE-Saúde), regulamentado por lei própria, e não de plano de saúde privado, inaplicáveis as disposições da ANS e da Lei 9.656/98.

> *A Lei nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.066/04, regulamentada o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul – IPE-Saúde, nos seguintes termos:*
>
> *Art. 1.º Fica reorganizado, na forma desta Lei Complementar, o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, denominado Sistema IPE Saúde, tendo como gestor o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde –, segundo os ditames da presente Lei Complementar, resoluções e regulamentos próprios.*
>
> *Art. 2.º É objetivo primordial do Sistema IPE Saúde a realização das operações de assistência à saúde aos servidores públicos dos Poderes de Estado, órgãos e entidades autônomas, previstas nas tabelas de cobertura do IPE Saúde, na forma prevista e autorizada nesta Lei Complementar, no respectivo Regulamento e nos atos normativos expedidos pelo Instituto.*
>
> *§ 1.º O Sistema de que trata o "caput" deste artigo é fundamentado nos princípios da coparticipação financeira dos usuários e da prestação de serviços de assistência médica, mediante credenciamento de profissionais e pessoas jurídicas da área da saúde.*
>
> *§ 2.º É vedada a utilização da denominação IPE Saúde com fins comerciais, publicitários e promocionais, sem autorização formal do Órgão Gestor, excetuando-se os prestadores regularmente credenciados junto ao Sistema de Assistência à Saúde.*
>
> *§ 3.º O Sistema de que trata o "caput" é constituído pelo Plano Principal e por Planos Suplementares e Complementares, que já existem, ou que venham a ser criados, para o aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade de cobertura prestada na área da saúde.*
>
> *Art. 3.º O ingresso e a permanência no Sistema assistencial de que trata esta Lei Complementar será facultativo, instruído conforme procedimento administrativo vigente e respeitados os prazos de carência.*
>
> *Art. 4.º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos*

tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.

§ 1.º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

§ 2.º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.

§ 3.º Para aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade de cobertura prestada na área da saúde, mediante prévio estudo técnico e atuarial, o Instituto poderá instituir Planos Especiais, para disponibilizar outros serviços ou procedimentos, cuja participação é opcional, mediante prévia solicitação e mensalidade específica, na forma que dispuserem o regulamento e atos normativos expedidos pelo Instituto.

Art. 5.º Compete ao Diretor-Presidente do Instituto expedir atos normativos que disciplinarão o funcionamento do Sistema assistencial de que trata esta Lei Complementar.

A Resolução nº 21/79 do IPE-Saúde que regulamenta a assistência médico-hospitalar, dispõe no art. 2º que o plano *"cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento"* dos associados e seus dependentes.

Assim, inobstante o § 1º do art. 4º da Lei nº 15.145/18, disponha sobre a exclusão da cobertura do IPE Saúde dos procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais não previstos nas tabelas próprias do Instituto, deve prevalecer a indicação médica a respeito do tratamento adequado ao paciente.

Portanto, descabe ao plano de assistência à saúde escolher a técnica a ser empregada no tratamento da segurada, a menos que comprovada cientificamente a inutilidade ou impropriedade da recomentação médica, mostrando-se, por consequência, abusiva a exclusão de procedimentos necessários ao tratamento da saúde da autora.

No caso, conforme relatado, a autora foi diagnosticada com Neoplasia maligna de outras glândulas salivares e Neoplasia Maligna Secundária Dos Órgãos Respiratórios e Digestivos.

Conforme o laudo médico, necessitou fazer uso do medicamento PERTUZUMABE + TRASTUZUMABE, com urgência, sendo que a não utilização do tratamento prescrito poderia significar pior controle da doença, com piora da dor e minuição do tempo de vida da paciente. Ainda, o médico assistente destaca que não há alternativa igualmente eficaz:

LAUDO MÉDICO

A paciente acima apresenta o diagnóstico de carcinoma de glândula salivar com metástases pulmonares. A análise tumoral demonstrou hiperexpressão do receptor HER2.
Os carcinomas de glândula salivar são tumores raros e as estratégias terapêuticas são menos padronizadas do que em tumores comuns como pulmão, mama ou próstata. Além disso, muitos carcinomas de glândula salivar podem ser resistentes à quimioterapia e a radioterapia limitando as opções terapêuticas.

Conforme diretrizes de tratamento oncológico internacionais (NCCN, ESMO) , não existe um tratamento padrão ou tratamento preferido para o carcinoma de glândula salivar. Conforme estas diretrizes, o uso de terapia anti-HER2 é uma estratégia válida em pacientes cujo tumor hiper-expressa o HER2, podendo ser altamente efetiva e pouco tóxica. Em estudos pequenos, o uso de trastuzumabe + pertuzumabe para tratamento do carcinoma de glândula salivar proporcionou uma taxa de resposta global de 60%, sem toxicidade significativa.

Portanto, é fundamental que a paciente receba o tratamento prescrito com urgência. Considerando o nível de evidência atual, este tratamento é o que apresenta maior probabilidade de sucesso terapêutico. A não utilização do tratamento prescrito pode significar pior controle de doença, com piora da dor e diminuição do tempo de vida da paciente.
Não há alternativa igualmente eficaz.
Declaro não possuir qualquer conflito de interesse na prescrição do medicamento em questão.

Portanto, suficientemente demonstrado pela prova amealhada que o tratamento é adequado e eficiente às necessidades da autora, sobretudo para manutenção de sua vida.

A negativa de cobertura é fato admitido pelo réu, prescindindo de prova nesse sentido (art. 374, II, CPC).

A respeito, a recente ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DARATUMUMABE (DALINVI®) E NAUSEDRON. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS EM ONCOLOGIA. RECUSA ILEGAL. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP). 2. No caso dos autos, opõe-se ré ao fornecimento do medicamento postulado pela parte autora sob o fundamento de que não há previsão de cobertura em suas atuais Recomendações Técnicas em Oncologia. Ocorre que, da análise dos autos, não se vislumbra a existência de alternativa terapêutica eficaz à condição que acomete a demandante. Desta feita, devidamente comprovada a necessidade dos medicamentos DARATUMUMABE (DALINVI®) e NAUSEDRON para o tratamento da moléstia que acomete a parte autora, impõe-se a condenação do IPE-SAÚDE ao seu fornecimento, ainda que ausente previsão expressa nas tabelas da autarquia previdenciária, em atenção ao entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. Juízo de procedência do pedido mantido em remessa necessária. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §8º, DO CPC. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nas causas referentes à saúde em que vencida a Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, uma vez que nestas ações, em que se busca preservar, ao fim e ao cabo, a vida, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte demandante. Tema 1255 ainda não julgado pelo e. STF. 2. Viável que a verba honorária seja majorada para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a jurisprudência desta Corte. 3. Apelo parcialmente provido. SENTENÇA CONFIRMADA EM

REMESSA NECESSÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50262404720228210021, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 14-10-2023)

Em relação à alegada incompatibilidade entre as obrigações do réu, como fundo de assistência médica estadual (natureza pública), e dos planos de saúde em geral (natureza privada), nada há nos autos a indicar minimamente que o fornecimento do tratamento necesário à autora afetará as finanças do plano de saúde.

Logo, abusiva a limitação do medicamento necessário ao tratamento da patologia, sob pena de substituição da atividade médica pelos padrões estabelecidos por quem se obrigou à cobertura das despesas com saúde, mediante robusta contraprestação.

Nessa ordem de ideias, comprovada a condição de segurada do plano de saúde e o diagnóstico, com recomendação médica de uso do medicamento postulado, a procedência do pedido é medida impositiva.

Em face do exposto, julgo procedente o pedido deduzido por COLOIR MACHADO DA SILVA em face de IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **PERTUZUMABE + TRASTUZUMABE, a taxa de sala, materiais e/ou medicamentos inerentes a aplicação hospitalar**, na quantidade indicada pelo médico responsável, enquanto perdurar a necessidade.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais vão fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, com correção monetária pelo IPCA a contar desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, considerado o trabalho desempenhado, a natureza da demanda e a extensão da controvérsia, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas para o réu, todavia condeno-o nas despesas processuais (Provimento nº 43/2020-CGJ).

Caso interposto recurso de apelação, cumpram-se as formalidades dos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do Código de Processo Civil, e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do RS.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, fulcro art. 496, § 3º, inciso II, do CPC[2], considerando que a condenação possui valor líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Preclusa a decisão, arquive-se com baixa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO NAZARIO, Juiz de Direito**, em 10/7/2024, às 14:30:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10063017763v8** e o código CRC **dcd5c9e6**.

---

2. "§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:(...)II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;" ↩